

사회복지실천론

사회복지실천에 대한 이해

사회복지실천의 목적

- 개인의 문제해결능력과 대처능력 향상, 개인과 환경 간 불균형 발생 시 문제 감소 원조
- 개인과 환경 간의 상호작용에 초점을 두고 사회정책개발
- 개인과 환경 간 상호 유익한 관계 증진
- 클라이언트의 삶의 질 증진
- 클라이언트의 기능성과 잠재력 개발
- 전적인 책임을 갖고 지속적 지원 X

사회복지실천의 기능

: 개인의 사회기능 증진, 사회정의 향상

사회복지실천의 이념과 철학

인도주의와 박애사상 : 인도주의적 서비스, 타인을 위해 봉사

사회진화론 : 자선조직협회 영향, 사회통제 기능

민주주의 : 자기결정권, 받는 자 중심, 선택적 봉사철학 강화, 인보관 운동 -> 사회개혁
서비스 제공자와 소비자의 동등한 관계 강조, 빈곤에 대한 사회적 책임 중시
서비스 이용자의 정책결정 참여

개인주의 : 개인권리 존중, 개별화 원칙, 수혜 자격 축소, 빈곤의 원인과 책임을 개인에게
최소한의 수혜자격 강조

Q. 개인주의가 사회복지실천에 미친 영향으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

ㄱ. 개별화 ㄴ. 개인의 권리와 의무 강조 ㄷ. 최소한의 수혜자격 원칙 ㄹ. 사회적 책임 중시

다원주의 : 다양한 계층과 문제 인정 계기, 역량강화 논의 활발

직접 실천

: 부모 상담, 정보 제공, 가족치료, 기술교육 제공, 취업상담, 재가 방문, 주간보호제공

- 장애인 취업상담
- 독거어르신 재가방문
- 치매어르신 주간보호 제공
- 정신장애인 사회기술훈련 실시

간접 실천

: 홍보활동, 자원봉사자 모집, 모금활동, 공청회, 프로그램 개발, 모금운동, 예산확보운동
캠페인, 클라이언트 옹호

- 아동학대 예방을 위한 홍보 활동
- 학교폭력 예방을 위한 자원봉사자 모집
- 희귀질환 아동을 위한 모금 활동
- 장애인 인식개선을 위한 지역사회 홍보활동을 한다.
- 가정폭력 피해여성을 위한 모금활동을 한다.
- 청소년 유해환경을 줄이기 위한 프로그램을 개발한다.
- 사각지대 발굴을 위해 이웃 주민을 조직한다.

Q. 사회복지실천의 간접적 개입에 해당하는 것은? (2)

1. 의사소통 교육 2. 프로그램 개발 3. 부모교육 4. 가족상담 5. 사회기술훈련

미시 수준 실천

: 개인상담, 정보제공, 사회기술훈련 제공, 가족치료, 위탁가정 아동 방문, 재할상담

: 청소서비스 제공, 공공부조서비스의 적격성을 파악하기 위한 욕구사정

중범위 수준 실천

: 기관이나 조직 내부, 기관이나 조직 간 상호작용 등에 개입

: 자조집단/지지집단 운영

- 지역사회보장협의체에서 기관실무자 네트워크 회의 소집

거시 수준 실천

: 지역사회나 전체 사회 혹은 국가의 복지체계 개입

: 정책 분석 및 평가, 모금활동, 정책대안 발굴, 제안된 법안 분석, 자원개발, 취약계층 옹호, 후원자 개발 및 관리, 노숙인 보호를 위한 모금활동, 직업재활 대상자를 위한 자원개발 등

: 사회복지관에서 후원자개발을 위한 행사 진행, 지역특성에 맞는 주민대상 프로그램 개발을 위한 지역조사 실시

Q. 거시 수준의 사회복지실천에 관한 내용으로 옳지 않은 것은? (2)

1. 다문화 청소년을 위한 조례 제정을 추진한다.
2. 부모와 자녀의 관계증진을 위한 소집단프로그램을 진행한다.
3. 피학대 노인 보호를 위한 제도 개선을 제안한다.
4. 장애인복지에 필요한 정부 예산 증액을 촉구한다.
5. 고독사 문제 해결을 위해 정책 토론회를 개최한다.

과학적 속성(=과학적 기반)

- 효과적 개입을 위해 사회현상, 사회적 조건과 문제, 사회정책과 프로그램, 사회복지 전문직, 다양한 실천 이론과 관련된 지식에 바탕을 두고 이를 적용, 활용하는 것
- 경험적 사실의 수집, 이론적 설명, 객관적 관찰, 단일사례설계를 이용한 프로그램 효과성 평가, 결식아동지원 프로그램 과정평가, 기술훈련 등

예술적 속성(=예술적 기반)

- 클라이언트의 정서적 측면에 개입하는 사회복지사의 심리적 특성 또는 능력을 적절히 활용
- 클라이언트의 전문적 관계 형성, 클라이언트에 대한 감정이 이입된 의사소통, 창의적 사고, 적합한 가치, 직관적 능력, 건전한 판단력, 사회적 관심, 타인의 고통을 진심으로 이해하고 공감하는 능력 등

사회복지의 전문성

그린우드 : 체계적 이론, 전문적 권위, 사회적 인가(=재가), 전문직 문화, 윤리강령

홀 : 전문적 조직의 활용, 공적 서비스에 대한 신념, 자기규율, 직업의식, 전문적인 자율성, 특수한 이론적 토대

사회복지실천의 가치와 윤리

가치

- 다수의 사회구성원이 좋거나 바람직하다고 믿는 신념
- 경험적으로 증명될 수 없음
- 방향 제시
- 시대와 사회에 따라 달라짐
- 신념과 관련이 있음

윤리

- 옳고 그름을 판단하는 기준(도덕적 지침)
- 행동화된 가치
- 윤리는 가치에서 파생됨
- 시대와 사회에 따라 달라짐
- 행동과 관련이 있음
- 사회복지사 윤리강령은 법적 구속력을 가지지 않는 특징이 있다.

사회복지실천 윤리

- 준거틀
- 전문직 보호, 클라이언트 보호
- 서로 다른 가치관 사이의 관계 정립
- 가치와 조화를 이루어야 한다.
- 전문적 실천활동의 지침을 제공한다.
- 사회복지 분야에서는 취약계층의 권리보호를 위해 특히 강조한다.

사회복지 전문직의 가치(레비)

사람 우선 가치(인간에 대한 바람직한 생각)

- 인간의 타고난 가치와 존엄성에 대한 믿음, 건설적인 변화의지와 능력에 대한 믿음, 상호적 책임, 소속의 욕구, 개별성에 대한 인정, 일반적인 인간적 욕구 등

결과 우선 가치(인간을 위한 바람직한 결과)

- 인간에게 바람직한 결과가 무엇인지를 알려주는 가치
- 부적절한 교육과 주택문제 등 사회적 문제의 제거, 평등한 기회 부여와 차별 금지 등

수단 우선 가치(인간을 다루는 바람직한 도구)

- 서비스를 수행하는 방법과 수단과 도구에 대한 가치
- 자기결정권 존중, 비심판적인 태도 유지 등

Q. 레비가 제시한 사회복지전문직의 가치 중 결과우선가치에 해당하는 것은? (4)

1. 자기 결정권 존중
2. 인간 존엄성에 대한 믿음
3. 비심판적 태도
4. 동등한 사회 참여 기회 제공
5. 개별성에 대한 인정

윤리적 결정의 철학적 근거

윤리적 절대주의 - 절대적 윤리법칙이 존재한다고 보는 관점

윤리적 상대주의 - 보편적으로 타당한 어떤 윤리법칙도 존재하지 않는다고 보는 관점

윤리적 상대주의 입장에서 본다면 사회복지사가 클라이언트의 비밀보장 권리를 지키는 것이 사회복지사의 윤리적 행동으로서 중요하지만 태아와 클라이언트의 건강과 복지를 지키는 것이 비밀보장보다 상대적으로 더 중요하다고 판단할 수 있음

윤리적 절대주의 입장에서 본다면 사회복지사는 클라이언트의 비밀보장 권리를 지켜주어야 하며 예외가 없기 때문에 부모에게 알려서는 안 된다고 판단

윤리적 갈등과 해결

갈등 발생 상황

- 가치 상충
- 의무 상충(충성심과 역할 상충)
- 클라이언트체계의 다중성
- 결과의 모호성
- 힘 또는 권력의 불균형

보호시설 입소를 원하지 않는 클라이언트와 시설 입소가 클라이언트에게 도움이 된다고 여기는 사회복지사 간에 상충되는 가치 : 자기결정-온정주의

윤리적 갈등을 조정할 때 고려하는 형식(돌고프와 로웬버그, 해링턴) - 윤리적 의사결정모델

1단계 : 무엇이 문제인지, 문제를 야기하는 요인은 무엇인지

2단계 : 클라이언트 및 피해자인지, 지치체계와 다른 전문가 등 관련된 사람과 단체는?

3단계 : 사회적 가치, 전문가로서의 가치, 클라이언트와 사회복지사의 개인적 가치 등 확인

4단계 : 개입목표 명확히

5단계 : 개입수단과 개입대상을 분명하게 확인

6단계 : 개입 방안의 효과성과 효율성 평가

7단계 : 의사결정에 참여할 사람 결정

8단계 : 가장 적절한 개입 방법 선택

9단계 : 개입방법 수행

10단계 : 개입방법 수행 검토, 예상하지 않았던 결과 확인

11단계 : 결과 평가, 추가 문제 검토

윤리적 원칙 심사(=준거틀)

윤리강령 등으로 해결되지 않는 경우 최후 수단으로 고려

여러 원칙이 충돌할 경우 상위의 원칙(숫자가 작은 것)을 먼저 적용함

1. 생명보호의 원칙

2. 평등과 불평등의 원칙

3. 자율과 자유의 원칙(자기결정의 원칙) : 도움을 요청해 온 클라이언트의 의사 존중

4. 최소 해악(=손실)의 원칙

5. 삶의 질의 원칙

6. 사생활 보호와 비밀보장의 원칙

7. 진실성과 정보 공개의 원칙(성실의 원칙, 정보개방의 원칙)

윤리강령의 개념과 기능

개념 : 윤리강령은 전문직이 윤리적 실천을 수행할 수 있도록 행동기준과 원칙을 정해놓은 구체적인 지침

기능 : 판단기준 제공, 기본 윤리적 행위가 무엇인지, 비윤리적 행동이 무엇인지 판단 기준

즉, 전문직을 외부의 규정으로부터 보호하고 전문직 실천 대상을 보호

법적 제재의 근거 제공 X

윤리강령은 국가가 채택 X

윤리강령

● 사회복지사의 기본적 윤리기준

1. 전문가로서의 자세

- 1) 사회복지사는 전문가로서의 품위와 자질을 유지하고, 자신이 맡고 있는 업무에 대해 책임을 진다.
- 2) 사회복지사는 클라이언트의 종교·인종·성·연령·국적·결혼상태·성적 지향·경제적 지위·정치적 신념·정신, 신체적 장애·기타 개인적 선호, 특징, 조건, 지위를 이유로 차별 대우를 하지 않는다.
- 3) 사회복지사는 전문가로서 성실하고 공정하게 업무를 수행하며, 이 과정에서 어떠한 부당한 압력에도 타협하지 않는다.
- 4) 사회복지사는 사회정의 실현과 클라이언트의 복지증진에 헌신하며, 이를 위한 환경 조성을 국가와 사회에 요구해야 한다.
- 5) 사회복지사는 전문적 가치와 판단에 따라 업무를 수행함에 있어, 기관 내외로부터 부당한 간섭이나 압력을 받지 않는다.
- 6) 사회복지사는 자신의 이익을 위해 사회복지 전문직의 가치와 권위를 훼손해서는 안 된다.
- 7) 사회복지사는 한국사회복지사협회 등 전문가단체 활동에 적극 참여하여, 사회정의 실현과 사회복지사의 권익 옹호를 위해 노력해야 한다.

2. 전문성 개발을 위한 노력

- 1) 사회복지사는 클라이언트에게 최상의 서비스를 제공하기 위해, 지식과 기술을 개발하는 데 최선을 다하며 이를 활용하고 전파할 책임이 있다.
- 2) 클라이언트를 대상으로 연구하는 사회복지사는 저들의 권리를 보장하기 위해, 자발적이고 고지된 동의를 얻어야 한다.
- 3) 연구 과정에서 얻은 정보는 비밀보장의 원칙에서 다루어져야 하고, 이 과정에서 클라이언트는 신체적, 정신적 불편이나 위험·위해 등으로부터 보호되어야 한다.
- 4) 사회복지사는 전문성을 개발하기 위해 노력하되, 이를 이유로 서비스의 제공을 소홀히 해서는 안 된다.
- 5) 사회복지사는 한국사회복지사협회 등이 실시하는 제반 교육에 적극 참여하여야 한다.

3. 경제적 이득에 대한 태도

- 1) 사회복지사는 클라이언트의 지불 능력에 상관없이 서비스를 제공해야 하며, 이를 이유로 차별대우를 해서는 안 된다.
- 2) 사회복지사는 필요한 경우에 제공된 서비스에 대해, 공정하고 합리적으로 이용료를 책정해야 한다.
- 3) 사회복지사는 업무와 관련하여 정당하지 않은 방법으로 경제적 이득을 취하여서는 안 된다.

● 사회복지사의 클라이언트에 대한 윤리기준

1. 클라이언트와의 관계

- 1) 사회복지사는 클라이언트의 권익 옹호를 최우선의 가치로 삼고 행동한다.
- 2) 사회복지사는 클라이언트에 대하여 인간으로서의 존엄성을 존중해야 하며, 전문적 기술과 능력을 최대한 발휘한다.
- 3) 사회복지사는 클라이언트가 자기 결정권을 최대한 행사할 수 있도록 도와야 하며, 저들의 이익을 최대한 대변해야 한다.
- 4) 사회복지사는 클라이언트의 사생활을 존중하고 보호하며, 직무 수행과정에서 얻은 정보에 대해 철저히 비밀을 유지해야 한다.
- 5) 사회복지사는 클라이언트가 받는 서비스의 범위와 내용에 대해, 정확하고 충분한 정보를 제공함으로써 알 권리를 인정하고 존중해야 한다.
- 6) 사회복지사는 문서·사진·컴퓨터 파일 등의 형태로 된 클라이언트의 정보에 대해 비밀보장의 한계·정보를 얻어야 하는 목적 및 활용에 대해 구체적으로 알려야 하며, 정보 공개 시에는 동의를 얻어야 한다.
- 7) 사회복지사는 개인적 이익을 위해 클라이언트와의 전문적 관계를 이용하여서는 안 된다.
- 8) 사회복지사는 어떠한 상황에서도 클라이언트와 부적절한 성적 관계를 가져서는 안 된다.
- 9) 사회복지사는 사회복지 증진을 위한 환경 조성에 클라이언트를 동반자로 인정하고 함께 일해야 한다.

2. 동료의 클라이언트와의 관계

- 1) 사회복지사는 적법하고도 적절한 논의 없이 동료 혹은, 다른 기관의 클라이언트와 전문적 관계를 맺어서는 안 된다.
- 2) 사회복지사는 긴급한 사정으로 인해 동료의 클라이언트를 맡게 된 경우, 자신의 의뢰인처럼 관심을 갖고 서비스를 제공한다.

● 사회복지사의 동료에 대한 윤리기준

1. 동 료

- 1) 사회복지사는 존중과 신뢰로서 동료를 대하며, 전문가로서의 지위와 인격을 훼손하는 언행을 하지 않는다.
- 2) 사회복지사는 사회복지 전문직의 이익과 권익을 증진시키기 위해 동료와 협력해야 한다.
- 3) 사회복지사는 동료의 윤리적이고 전문적인 행위를 촉진시켜야 하며, 이에 반하는 경우에는 제반 법률규정이나 윤리기준에 따라 대처해야 한다.
- 4) 사회복지사가 전문적인 판단과 실천이 미흡하여 문제를 야기시켰을 때에는, 적절한 조치를 취하여 클라이언트의 이익을 보호해야 한다.
- 5) 사회복지사는 전문직 내 다른 구성원이 행한 비윤리적 행위에 대해, 제반 법률규정이나 윤리기준에 따라 조치를 취해야 한다.
- 6) 사회복지사는 동료 및 타 전문직 동료의 직무 가치와 내용을 인정.이해하며, 상호 간에 민주적인 직무 관계를 이루도록 노력해야 한다.

2. 수퍼바이저

- 1) 수퍼바이저는 개인적인 이익의 추구를 위해 자신의 지위를 이용해서는 안 된다.
- 2) 수퍼바이저는 전문직 기준에 의해 공정하게 책임을 수행하며, 사회복지사.수련생 및 실습생에 대한 평가는 저들과 공유해야 한다.
- 3) 사회복지사는 수퍼바이저의 전문적 지도와 조언을 존중해야 하며, 수퍼바이저는 사회복지사의 전문적 업무수행을 도와야 한다.
- 4) 수퍼바이저는 사회복지사, 수련생 및 실습생에 대해 인격적.성적으로 수치심을 주는 행위를 해서는 안 된다.

● 사회복지사의 사회에 대한 윤리기준

- 1) 사회복지사는 인권존중과 인간 평등을 위해 헌신해야 하며, 사회적 약자를 옹호하고 대변하는 일을 주도해야 한다.
- 2) 사회복지사는 필요한 사회서비스를 개발하기 위한 사회정책의 수립.발전.입법.집행에 적극적으로 참여하고 지원해야 한다.
- 3) 사회복지사는 사회환경을 개선하고 사회정의를 증진시키기 위한 사회정책의 수립.발전.입법.집행을 요구하고 옹호해야 한다.
- 4) 사회복지사는 자신이 일하는 지역사회의 문제를 이해하고, 그것을 해결하는 일에 적극적으로 참여해야 한다.

● 사회복지사의 기관에 대한 윤리기준

- 1) 사회복지사는 기관의 정책과 사업 목표의 달성.서비스의 효율성과 효과성의 증진을 위해 노력함으로써, 클라이언트에게 이익이 되도록 해야 한다.
- 2) 사회복지사는 기관의 부당한 정책이나 요구에 대하여, 전문직의 가치와 지식을 근거로 이에 대응하고 즉시 사회복지윤리위원회에 보고해야 한다.
- 3) 사회복지사는 소속기관 활동에 적극 참여함으로써, 기관의 성장발전을 위해 노력해야 한다.

● 사회복지윤리위원회의 구성과 운영

- 1) 한국사회복지사협회는 사회복지윤리위원회를 구성하여, 사회복지윤리실천의 질적인 향상을 도모하여야 한다.
- 2) 사회복지윤리위원회는 윤리강령을 위배하거나 침해하는 행위를 접수받아, 공식적인 절차를 통해 대처하여야 한다.
- 3) 사회복지사는 한국사회복지사협회의 윤리적 권고와 결정을 존중하여야 한다.

서구 사회복지실천의 역사적 발달

1. 태동기

자선조직협회

- 신흥 자본가와 중산층 주도, 개인 책임, 개인의 도덕성 개혁, 중복 구제 방지를 위한 자선활동 조정, 가치 있는 빈민, 가치 없는 빈민을 구분하여 원조 제공
- 개별 사회복지실천, 사회복지 조사, 지역사회 조직
- 빈곤 발생의 사회적 원인 경시, 과학적 자선, 영국 런던에서 시작, 우애방문자 활동

Q. 자선조직협회 활동에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (3)

1. 민간 사회복지기관의 활동을 체계적으로 조정하기 위해 등장하였다,
2. 적자생존에 기반한 사회진화론을 구빈의 이론적 기반으로 삼았다,
3. 빈민지역에 거주하며 지역사회 문제에 대한 집합적이고 개혁적인 해결을 강조하였다.
4. 과학적이고 적절한 자선활동을 수행하기 위해 클라이언트 등록체계를 실시하였다.
5. 자선조직협회 활동은 개별사회사업의 초석이 되었다.

인보관운동

- 영국 토인비 홀(1884), 성직자와 대학생 등 지식인 주도, 지역주민과 함께 거주
- 사회구조적 책임, 사회개혁, 빈민의 교육과 발전 도모, 환경 개선 교육
- 역량강화, 집단 사회복지실천, 지역사회 조직
- 3R : Residence(거주), Research(연구조사), Reform(개혁)

2. 전문적 확립기

1905 : 유급 사회복지사 등장, 의사인 카보트가 매사추세츠병원에 의료사회복지사 정식 채용

-> 카보트는 전문직 출발 계기가 아님, 플렉스너 비판에 대한 반응이 아님

1907 : 시카고대학교에 사회복지 교육 프로그램 개설

1915 : 플렉스너 연설, 사회복지사는 전문직인가, 전문직이 아니라 중개인이라고 주장

- 사회복지사는 사회과학적 기초가 결여되어 있다.
- 사회복지사는 독자적이고 명확한 지시체계와 가르치고 배울 수 있는 전문기술이 없다.
- 정부의 책임하에 실시되는 교육제도와 전문적자격제도가 없다.
- (협회와 같은 전문가를 위한)전문직 조직체가 없다.
- 전문적인 실천에 대한 윤리강령이 없다.

플렉스너의 비판에 대한 반응

1917 : 리치몬드의 사회진단, 미국에 17개의 사회복지 대학 생김

1921 : 미국사회복지사협회 설립

1929 : 밀포드 회의에서 개별사회사업 방법론을 기본으로 하는 사회복지실천의 공통요소 발표
사회복지사들이 치료자로서의 역할을 강조하면서 위상을 높이하고자 함

: 전문직으로 자리매김하기 위해 실천대상 영역을 좁혀 정신의학 중심의 실천과 치료자로서의 역할을 강조

3. 3대 방법론 분화/확립기

개별사회복지실천 -> 3대 방법론(개별사회복지실천, 집단사회복지실천, 지역사회조직)

진단주의와 기능주의 대립, 진단주의와 기능주의 절충 : 펄만의 문제해결모델(1957)

진단주의 : 프로이드의 정신분석이론에 영향, 무의식의 힘, 과거의 힘, 기계적, 결정론적인 인간관, 치료 중심, 질병의 심리학, 심리사회모델, 메리 리치몬드, 시간 제한 X

기능주의 : 대공황 이후 1930년대 등장, 인간의 의지 강조, 개인의 성장 가능성, 낙관적 견해, 원조 과정, 기관의 기능 중심, 성장의 심리학, 메리 오토 랭크

4. 통합적 접근과 다양화기

- 통합에 관한 노력은 1929년 밀포드 회의에서 찾을 수 있으나 1950년대 후반에 시작되어 1960년대에 본격화되었고 1970년대 이후까지 이어짐

- 통합적 방법론 등장 : 펄만의 문제해결모델(1957), 핀커스와 미나한의 4체계모델(1973), 콤프턴과 갤러웨이의 6체계 모델(1994)과 5체계 모델(1999), 골드스타인의 단일화모델(1973), 생활모델(1980) 등

- 다양화기 : 다양한 이론적 관점 수용, 생태체계관점, 클라이언트의 상황에 맞는 역할 및 개입 전략의 다중성 중시

5. 우리나라 사회복지실천의 역사

1921 : 태화여자관(우리나라 최초의 복지관) 설립

1947 : 이화여자대학교에서 대학 정규 과정으로 사회복지 교육 시작

1965 : 한국사회사업교육연합회 창설, 개별사회사업가협회 창립총회

1967 : 개별사회사업가협회를 한국사회사업가협회로 개칭 및 창립총회

1970 : 한국 사회복지사업법 제정

1983 : 사회복지사업법 개정, 사회복지관의 설립 및 운영을 지원하는 근거 마련

1987 : 사회복지전문요원제도 신설

1989 : 영구임대아파트 단지 내 사회복지관 설치 의무화

1997 : 정신보건사회복지사제도 시행

2000 : 법 개정으로 9월 7일 사회복지의 날 제정

2003 : 1회 사회복지사 1급 자격시험 실시, 사회복지사업법 개정, 지역사회복지협의체 법제화

2004 : 사회복지사무소 시범사업 실시

2005 : 1회 학교사회복지사 자격시험

2005 : 지역사회복지협의체 시행

※역사

사회복지실천 전문직으로서의 발전과정에서 플렉스너의 비판에 대한 반응에 해당하지 않는 것은? (4)

1. 리치몬드가 사회진단을 출간하였다.
2. 밀포드 회의에서 개별사회사업방법론을 기본으로 하는 사회복지실천의 공통요소가 정리되어 발표되었다.
3. 미국사회복지사협회가 설립되었다.
4. 의사인 카보트가 메사추세츠 병원에 의료사회복지사를 정식으로 채용하였다.
5. 사회복지사들이 치료자로서의 역할을 강조하면서 위상을 높이하고자 하였다.

사회복지실천의 발달과정을 순서대로 바르게 나열한 것은?

- ㄱ. 한국의 사회복지사업법이 제정되었다.
- ㄴ. 리치몬드의 사회진단이 출간되었다.
- ㄷ. 밀포드 회의에서 개별사회사업의 공통요소를 정리하였다.
- ㄹ. 펄만의 문제해결모델이 등장하였다.

ㄴ-ㄷ-ㄹ-ㄱ

사회복지실천의 공통된 원리에 기반하여 원조함

펄만의 문제해결모델이 대표적 예임

다양해지는 사회문제에 분화된 접근으로 대응할 수 없다는 인식에 기초함

통합적 접근 전에 일어난 일은

플렉스너의 사회복지직 전문성 비판 - 리치몬드의 사회진단 출간 - 사회복지실천 3대 방법론으로 분화 순

Q. 사회복지실천의 역사적 발달과정을 발생한 순서대로 옳게 나열한 것은?

- ㄱ. 밀포드 회의에서 사회복지실천의 공통요소를 발표하였다.
- ㄴ. 사회복지사업법에 따라 국내에서 사회복지사 명칭을 사용하기 시작하였다.
- ㄷ. 태화여자관이 설립되었다.
- ㄹ. 사회복지전문요원이 국내 행정기관에 배치되었다.

ㄷ-ㄱ-ㄴ-ㄹ

※사회복지 전문직

- 서구에서 전문직 교육과정이 시작된 것은 19세기 후반이다.
- 실천의 가치와 지식은 방법을 통해 현장에서 구현된다.
- 한국 사회복지사의 자격 및 처우에 관한 사항은 사회복지사업법에 근거한다.
- 밀포드 회의에서 사회복지실천의 공통요소를 제시하였다.
- 체계적 이론과 전문적 권위, 윤리강령, 사회적 인가는 그린우드가 제시한 전문직 속성

사회복지실천 현장에 대한 이해

1차 현장 : 지역사회복지관, 노인복지관, 양육시설, 장애인복지관, 자활지원센터 등

2차 현장 : 병원, 학교, 주민센터, 정신건강복지센터, 보육시설, 노인전문요양병원, 보호관찰소

공공기관 : 보건복지부, 시도사회복지과, 시군구 사회복지과, 주민센터 등

민간기관 : 사회복지법인이나 재단, 사단법인, 종교단체, 시민사회단체, 한국사회복지사협회, 사회복지공동모금회, 성폭력 피해상담소 등

간접 서비스 기관 : 한국사회복지협의회, 사회복지공동모금회 등

직접 서비스 기관 : 아동상담소, 지역사회복지관 등

생활시설 : 장애인생활시설, 보육원, 청소년쉼터, 그룹 홈(=공동생활가정), 자립지원시설 등

이용시설 : 주거 서비스 X, 재가복지센터, 지역사회종합복지관, 장애인복지관, 청소년상담복지센터, 치매노인 주간보호센터 등

노인의료복지시설 : 생활시설 - 노인요양시설, 노인요양공동생활가정

보건복지부 소관 : 지역아동센터, 중앙가정위탁지원센터, 자립지원시설 등

여성가족부 소관 : 청소년 쉼터, 청소년상담복지센터, 건강가정지원센터, 다문화가족지원센터, 가족통합지원센터 등

Q. 사회복지 실천현장과 분류의 연결로 옳지 않은 것은? (4)

1. 사회복지관 - 1차 현장
2. 종합병원 - 2차 현장
3. 발달장애인지원센터 - 이용시설
4. 노인보호전문기관 - 생활시설
5. 사회복지공동모금회 - 비영리기관

사회복지사 역할

조력자(=조정자) : 스스로 문제를 해결할 수 있는 능력을 기르고 필요한 자원을 찾아내도록

- 알코올중독자가 자신의 문제를 깨닫고 금주방법을 찾도록 도와주는 것

중개자 : 개인이나 집단을 지역사회의 서비스와 연결

- 가족이 없는 중증장애인에게 주거시설을 소개해 주는 것

옹호자

- 장애학생의 교육권 확보를 위해 학교당국에 편의시설을 요구하는 것

교사(교육자)

중재자 : 의사소통의 갈등이나 의견 차이를 중립적인 입장에서 조정하는 역할

- 갈등으로 이혼위기에 처한 부부관계에 개입하여 상호 만족스러운 합의점 도출

협상가

- 돌봄서비스를 받고 있는 노인과 직원 간 갈등을 해결하기 위해서 노인의 입장에서 해결

직접 서비스 제공 기능 : 상담가, 가족치료사, 집단사회복지지도자, 정보제공 및 교육자

체계 연결 기능 : 중개자, 사례관리자, 옹호자, 중재자, 조정자

체계 유지 및 강화 기능

유지 : 팀 성원

강화 : 조직분석가, 조직 내 촉진자, 자문가/자문 대상자, 슈퍼바이저

체계 개발 기능 : 프로그램 개발자, 기획자, 정책 및 절차 개발 참여자

연구자/연구활용자 기능 : 프로그램 평가자

Q. 양자 간의 논쟁에 개입하여 중립을 지키면서 상호합의를 이끌어내는 사회복지사의 역할은? 중재자

통합적 접근

등장배경 : 전통적 방법론의 한계

- 전통적 방법론은 주로 특정 문제 중심 개입
- 지나친 분화와 전문화로 서비스의 파편화 초래
- 공통기반이 없는 분화와 전문화로 영역 사이에 의사소통 혼란 초래
- 사회복지 전문직의 정체성 확립에 장애요인으로 작용
- 사회복지 지식체계에 사회체계이론 도입
- 클라이언트 문제는 여러 체계의 상호작용 결과라는 인식 확산
- 다양한 실천방법의 공통요소는 '문제해결'임을 발견

통합적 접근의 특징

- 방법론 간 공통된 기반 강조
- 인간과 환경 두 체계의 공유영역에 개입
- 이론과 개입에 개방적
- 클라이언트에 대한 강점관점, 미래지향적 관점을 취함
- 클라이언트의 존엄성 인정
- 생태체계관점, 광범위하고 포괄적인 문제 규정
- 다중체계 개입(미시적+거시적)
- 문제해결 과정
- 일반주의 실천
- 2궤도 접근 X(기능주의, 원인론적 궤도로 이분화)

※ 사회복지실천에서 통합적 방법에 대한 설명으로 옳은 것은? (2)

1. 사례관리가 실천현장에서 일반화된 이후 등장하였다.
2. 다양한 클라이언트 체계와 수준에 접근할 수 있다.
3. 고도의 전문화를 통해 해당 실천영역 고유의 문제에 집중한다.
4. 전통적 방법에 비하여 다양하고 복잡한 문제 상황에 개입하기에 적합하지 않다.
5. 다양한 유형의 클라이언트를 통합한다는 의미를 가진다.

※ 통합적 방법의 특징으로 옳지 않은 것은? (4)

1. 실천의 유용한 이론적 틀로서 생태체계적 관점에 기초한다.
2. 개인과 체계 간의 상호작용에 초점을 둔다.
3. 사회복지사는 미시적 수준에서부터 거시적 수준의 실천까지 다양한 체계에 개입한다.
4. 인간에 초점을 두거나 환경에 초점을 두는 2궤도 접근이다.
5. 일반주의 실천에서 활용하는 접근방법이다.

Q. 통합적 접근의 특징에 관한 내용으로 옳지 않은 것은? (5)

1. 생태체계 관점에서 인간과 환경 체계를 고려한다.
2. 미시 수준에서 거시 수준에 이르는 다차원적 접근을 한다.
3. 개입에 적합한 이론과 방법을 폭넓게 활용한다.
4. 다양하고 복합적인 원인으로 발생하는 문제를 해결하기 위한 접근이다.
5. 서비스 영역별로 분화되고 전문화된 접근이다.

※ 임파워먼트 모델

- 활용 가능한 자원 확보
- 클라이언트와 사회복지사의 역할 정하기
- 권리와 함께 클라이언트의 책임 강조
- 클라이언트 감정의 구체화
- 임파워먼트는 개인, 대인관계, 제도적 차원에서 이루어짐
- 클라이언트를 문제해결의 협력적 파트너로 인정함
- 클라이언트를 위해 자원을 동원하거나 권리를 옹호함
- 클라이언트와 문제해결 방안을 함께 수립한다.
- 클라이언트와 협력관계를 확립하는 것을 중요시한다.
- 개입과정은 대화-발견-발전 단계로 진행된다.

Q. 다음에서 설명하고 있는 사회복지실천모델은?

- 비장애인이 대부분인 사회에서 장애인 클라이언트의 취약한 권리에 주목하였다.
- 사회복지사와 클라이언트 집단은 장애인의 권익을 옹호하는데 협력하였다.
- 대화, 발견, 발전의 단계를 통해 클라이언트 집단은 주도적으로 불평등한 사회제도를 개선하였다.

: 임파워먼트모델

강점관점

- 역량강화의 활용
- 희망과 용기의 강조
- 개입의 초점이 가능성에 있다.
- 외상과 학대 경험은 클라이언트에게 도전과 기회의 원천이 될 수 있다.
- 모든 환경 속에는 활용 가능한 자원이 있다.
- 사회복지사와 클라이언트의 협동작업이 이루어질 때 클라이언트에게 최선의 도움이 주어질 수 있다.
- 대표적인 학자로 켈리비와 밀리가 있다.
- 실천의 초점을 과거에서 현재와 미래로 전환함
- 클라이언트를 재능과 자원을 가진 사람으로 규정한다.
- 개입의 핵심은 개인, 가족, 지역사회 참여다.
- 돕는 목적은 클라이언트의 삶에 함께 하며 가치를 확고히 하도록 지원하는 것이다.

4체계 모델(핀커스 & 미나한)

변화매개체계 : 기관 및 조직

-> 사회복지사와 사회복지사가 속한 기관

-> 중독관리 통합지원센터에 의뢰된 클라이언트. 중독치료 전문가가 변화매개체계

클라이언트체계 : 개인, 가족, 집단, 기관이나 지역사회

표적체계 : 영향을 주거나 변화시킬 필요가 있다고 느끼는 사람들

행동체계 : 이웃, 가족, 전문가

-> 문제해결을 위해 사회복지사와 상호작용 하는 사람들

콧튼과 갤러웨이의 5체계 모델, 6체계 모델

4체계 + 전문가 체계(5체계) + 의뢰-응답체계(6체계)

전문가 체계 : 전문가 단체, 전문적 실천의 가치, 사회복지사 윤리강령, 사회복지사협회나 사회복지 기관

의뢰-응답 체계 : 의뢰 체계는 서비스를 요청한 체계이며, 응답자체계는 법원이나 경찰, 외부 전문가 등의 요청에 의해 서비스 기관으로 오게된 체계로 구분하기도 함. 자발적으로 사회복지기관에 온 클라이언트와 구별하기 위해 사용됨

Q. 콧튼과 갤러웨이의 사회복지실천 구성체계 중 '사회복지사협회'가 해당되는 체계는?

: 전문가체계

사회복지실천의 전문적 관계

전문적 관계의 특징

- 의도적인 목적
- 시간제한적
- 클라이언트를 위한 것
- 통제된 관계
- 권위
- 관계에 책임을 짐(책임성)

전문적 관계의 요소와 사회복지사의 자질

: 헌신과 의무, 클라이언트에 대한 관심과 도우려는 의지, 권위와 권한, 진실성과 일치성
수용, 정서, 감정이입, 민감성, 사회복지사의 자기노출, 사회복지사의 자아인식, 직면 혹은 대응, 공감

Q. 사회복지실천의 전문적 관계에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (3)

1. 사회복지사와 클라이언트가 합의하여 목적을 설정한다.
2. 사회복지사는 소속된 기관의 특성에 영향을 받는다.
3. 사회복지사의 이익과 욕구 충족을 위한 일방적 관계이다.
4. 사회복지사는 전문성에 바탕을 둔 권위를 가진다.
5. 계약에 의해 이루어지는 시간제한적인 특징을 갖는다.

Q. 다음에서 설명하고 있는 것은?

사회복지사가 자신의 가치, 신념, 행동습관, 편견 등이 사회복지실천에 어떤 영향을 미치는지 정확하게 이해하는 것이다.

: 자기인식

Q. 원조관계에서 사회복지사의 태도에 관한 내용으로 옳은 것은? (4)

1. 개선의 여지가 있다고 판단된 경우에 한해서 클라이언트와 전문적 관계를 형성하였다.
2. 클라이언트의 감정에 이입되어 면담을 지속할 수 없었다.
3. 자신의 생각과 다른 클라이언트의 의견은 관계형성을 위해 즉시 수정하도록 지시하였다.
4. 법정으로부터 정보공개 명령을 받고 관련된 클라이언트 정보를 제공하였다.
5. 클라이언트 특성이나 상황이 일반적인 경우와 다르지만 획일화된 서비스를 그대로 제공하였다.

Q. 다음에서 설명하고 있는 사회복지사의 자질은?

- 클라이언트의 감정을 잘 관찰하는 것과 경청하는 과정에서 비롯된다.
- 클라이언트가 언어적으로 표현한 것뿐만 아니라 표현하지 않은 비언어적 내용들도 파악한다

: 민감성

✎ 전문적 관계의 기본 요소 중 자기 인식을 바탕으로 사회복지사의 감정과 반응을 있는 그대로 클라이언트에게 전달하는 능력은?

: 진실성

✎ 사회복지사의 다문화 역량을 높이기 위한 활동으로 옳지 않은 것은? (5)

1. 소수인종에 대한 선입관이나 편견을 탐색한다.
2. 사회적 차별에 맞서는 단체들의 활동을 분석한다.
3. 사회복지 전문직의 윤리적 행동지침을 이해한다.
4. 문화적 특성을 이해하기 위해 다양한 문화를 경험한다.
5. 동화의 중요성을 강조하는 문화상대주의에 대해 학습한다.

✎ 클라이언트가 과거에 타인과의 관계에서 경험하였던 소망이나 두려움 등의 감정을 사회복지사에게 보이는 반응은? 전이

✎ 클라이언트를 감동시키려고 노력하는 것은 바람직한 원조관계 형성에 방해가 되는 것이다.

✎ 문화적 다양성과 사회복지실천에 관한 설명으로 옳은 것은? (1)

1. 다문화주의는 문화상대주의다.
2. 다문화 사회복지실천에서 기술은 지식보다 중요하다.
3. 다문화주의는 사회통합을 위해 소수자의 동화를 유도한다.
4. 다문화 사회복지실천은 클라이언트의 차이점을 고려하지 않는 중립적 실천이다.
5. 사회복지사는 한국 사회복지사 윤리강령에 명시된 다문화적 역량증진 의무를 준수해야 한다.

✎ 다음 내용을 모두 충족하는 원조관계의 기본 요소는? 헌신과 의무

- 사회복지사와 클라이언트의 책임감을 의미하는 것으로 관계의 목적을 이루기 위해 서로를 신뢰하고 일관된 태도를 유지함
- 클라이언트는 문제와 상황을 솔직하게 말해야 하고, 사회복지사는 클라이언트의 변화와 성장을 위해 노력해야 함

✎ 전문직 원조관계의 특성으로 옳은 것은? (2)

1. 사회복지사는 클라이언트에 비해 우월적 지위에 있다.
2. 클라이언트에게 도움을 주기 위해 정해진 기간 동안 관계를 맺는다.
3. 사회복지사의 욕구에 부응하기 위해 상호 만족스러운 관계를 형성한다.
4. 관계의 전반적인 과정에 대해 사회복지사와 클라이언트가 공동으로 책임진다.
5. 전문적 관계를 통해 사회복지사는 클라이언트의 감정과 행동의 변화를 통제한다.

관계형성의 원칙

- 개별화 : 편견이나 고정관념 없이 클라이언트 개인의 경험을 존중
- 의도적인 감정표현 : 클라이언트가 자신이 비난받게 될지 모르는 감정을 자유롭게 표현
- 통제된 정서적 관여 : 피해학생의 분노와 공포감을 민감하게 이해하고 적절하게 반응
- 수용 : 신뢰, 감정 존중, 경청하는 태도, 민감한 반응, 흥미와 관심 전달하는 표정
- 비심판적 태도
- 자기결정 : 학생의 자퇴 결정을 존중함
- : 경청하고 수용하는 태도
- : 클라이언트가 활용 가능한 자원을 찾고 분석하도록 지원하는 능력
- : 클라이언트의 잠재력을 개발하는 데 도움이 되는 환경조성 능력
- 비밀보장 : 학생의 뜻에 따라 부모의 이혼사실을 교사에게 알리지 않음
- 자기결정의 제한
- 비밀보장의 한계
- : 법정으로부터 클라이언트의 정보공개명령을 받았을 때
- : 클라이언트의 치료를 위해 전문가 회의를 할 때
- : 클라이언트 자신이나 상대방의 생명에 위협이 될 때

Q. 비스텍의 관계의 원칙 중 '의도적 감정표현'에 해당하는 것은? (1)

1. 클라이언트의 부정적 감정을 자유롭게 표현할 수 있도록 지지한다.
2. 클라이언트의 감정이나 태도를 있는 그대로 받아들이고 존중한다.
3. 목적달성을 위한 방안들의 장·단점을 설명하고 클라이언트가 스스로 선택하도록 한다.
4. 공감을 받고 싶어 하는 클라이언트의 욕구에 따라 클라이언트에게 공감하는 반응을 표현한다.
5. 사회복지사 자신의 생각과 느낌, 개인적인 경험을 이야기 한다.

면접

- 면담을 하기 위한 세팅과 맥락이 있음
- 목적과 방향
- 계약에 의해 수행
- 특정한 역할관계
- 공식적인 활동
- 단계마다 면접의 목적이 달라짐
- 필요에 따라 여러 장소에서 수행됨
- 기관의 상황적 특성과 맥락에서 이뤄짐
- 개입목적에 따라 의사소통 내용이 제한됨

정보수집을 위한 면접

사정을 위한 면접

- 문제상황에 대한 이해, 클라이언트의 강점 파악, 문제해결과정의 장애물 탐색, 클라이언트의 욕구 우선순위 설정, 문제해결 목표를 달성하기 위한 개입방법을 결정

치료를 위한 면접

면접의 구조적 조건

- 면접 장소는 유동적으로
- 면접 시간 조절
- 편안한 의자 제공
- 클라이언트와 지나치게 가까우면 비효과적

면접 기술

- 명료화 : 좀 더 분명하고 객관적인 인식을 갖도록 격려
- 직면 : 감정, 사고, 행동의 모순을 깨닫도록
- 해석 : 클라이언트의 행동, 저변의 단서를 발견하고 결정적 요인을 찾도록 도움
- 요약 : 생각, 행동, 감정을 사회복지사의 언어로 정리
- 초점제공 기술 : 벗어나는 이야기로 흐를 경우 면접의 초점으로 다시 돌아오게 하는 기술
- 재보증(안심) : 클라이언트의 불안과 불확실성 제거하고 위안을 주는 기술
- 재명명 : 클라이언트의 시각을 긍정적인 방향으로 변화시키는 기술
- 환기법 : 문제 또는 상황과 관련된 감정 표출
- 격려 : 행동과 태도, 감정을 칭찬하거나 인정해 주는 기술
- 타임아웃 : 바람직하지 않은 행동을 중단시키기 위한 기법, 부적 처벌의 원리
- 일반화 : 혼자만 가지고 있는 문제가 아니라는 것을 인식하게 해주는 기법

Q. 클라이언트와의 면접 중에 주제를 전환하기 위한 목적으로 사용하는 실천기술은? (2)

1. 반영 2. 요약 3. 해석 4. 직면 5. 초점화

-> 실천기술론 21회 문제였음

면접에서 클라이언트의 침묵 다루기

- 침묵하는 이유 파악
- 침묵을 기다리는 배려 필요
- 침묵을 저항의 한 유형으로 이해
- 침묵이 계속되면 면접 중단 가능

☞ 면접 옳은 것

- 사회복지사와 클라이언트 사이의 특정한 역할 관계가 있다.
- 시간과 장소 등 구체적인 요건이 필요하다.
- 클라이언트의 어려움을 극복하는 데 필요한 변화들을 가져오기도 한다.
- 클라이언트를 이해하는 데 필요한 정보를 수집하기도 한다.
- 사회복지사에 관한 사적인 질문은 가능한 한 간결하게 답하고, 초점을 다시 클라이언트에게 돌린다.
- 클라이언트와의 신뢰관계가 충분히 형성된 후에 해석기술을 활용한다.
- 클라이언트의 표현이 모호할 때는 오해를 최소화하기 위해 구체적 표현을 요청한다.
- 클라이언트의 비언어적 표현을 관찰할 때는 신중해야 한다.
- 물리적인 환경이 열악한 경우 이에 대해 설명한다.
- 클라이언트의 특성이나 사정에 따라 면접장소는 유동적으로 정한다.
- 클라이언트의 주의집중능력이나 의사소통능력에 따라 면접시간을 조절한다.
- 클라이언트의 긴장을 완화시키고 집중도를 높일 수 있는 편안한 의자를 제공한다.
- 초기 면접에서 클라이언트가 불안해하면 안심시키는 것이 필요하다.
- 침묵을 기다리고 침묵하는 이유를 파악한다.
- 침묵이 계속되면 면접을 중단할 수 있다.

☞ 면접 옳지 않은 것

- 목적보다는 과정 지향적 활동이므로 목적에 집착하는 것을 지양한다.
- 클라이언트가 지나치게 말을 많이 하는 경우, 폐쇄형 질문만을 사용하여 초점을 모으는 것이 필요하다.
- 클라이언트와의 거리는 가까울수록 효과적이다.
- 클라이언트가 상반된 이야기를 하더라도 관계형성을 위해 그대로 진행한다.
- 사회복지사는 클라이언트의 호기심 해소에 초점을 맞추어 면접을 진행한다.
- 사회복지사의 관심을 끌기 위한 질문은 관계형성에 도움이 되므로 계속 응대한다.
- 클라이언트가 하고 싶어 하는 이야기는 시간에 관계없이 경청한다.
- 한 번에 다양한 정보를 얻기 위해서는 중첩형 질문을 적극적으로 활용해야 한다.
- 클라이언트의 침묵은 저항이므로 힘들더라도 대화를 지속하도록 촉구해야 한다.
- 클라이언트가 받아들이기 어려운 경우에도 자기탐색을 위해 해석을 반복한다.
- 바람직한 결정을 이끌어내기 위해 원하는 방향으로 유도질문을 하는 것이 중요하다.
- 침묵의 이유를 알 때까지 질문한다.

Q. 사회복지실천 면접의 질문기술에 관한 내용으로 옳은 것은? (1)

1. 클라이언트가 방어적인 태도를 취할 수 있기에 '왜'라는 질문은 피한다.
2. 클라이언트가 자유롭게 대답할 수 있도록 폐쇄형 질문을 활용한다.
3. 사회복지사가 의도하는 특정방향으로 이끌기 위해 유도 질문을 사용한다.
4. 클라이언트에게 이중 또는 삼중 질문을 한다.
5. 클라이언트가 개인적으로 궁금해 하는 사적인 질문은 거짓으로 답한다.

Q. 다음에서 설명하고 있는 면접 기술은? 환기

- 클라이언트가 말하는 것만으로도 치료효과를 얻을 수 있다.
- 클라이언트의 억압된 또는 부정적인 감정이 문제해결을 방해하거나 감정자체에 문제가 있는 경우 이를 표출하게 하여 감정을 해소시키려 할 때 활용한다.

Q. 사회복지실천 개입기술에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은? (ㄱ)

- ㄱ. 재보증은 어떤 문제에 대해 클라이언트가 부여하는 의미를 수정해 줌으로써 클라이언트의 시각을 긍정적인 방향으로 변화시키려는 전략이다.
- ㄴ. 모델링은 실제 다른 사람의 행동을 직접 관찰함으로써만 시행 가능하다.
- ㄷ. 격려기법은 주로 클라이언트 행동이 변화에 장애가 되거나 타인에게 위협이 될 때, 이를 인식하도록 하기 위한 목적으로 사용한다.
- ㄹ. 일반화란 클라이언트 혼자만이 겪는 문제가 아니라는 것을 인식하게 하는 기법이다.

사회복지실천 과정

1. 접수

- 서비스의 적격 여부 판단, 문제 확인, 의뢰 결정, 관계형성, 양가감정 수용, 저항감 해소, 동기화
- 기관의 서비스와 원조 과정에 대한 안내, 자격요건, 이용절차, 비용 등을 상세하게 설명

2. 자료수집

- 필요한 자료 수집
- 문제에 관한 정보, 최근까지의 상황, 클라이언트 개인력, 클라이언트 가족력, 클라이언트의 기능, 클라이언트의 강점과 한계, 클라이언트의 환경
- 클라이언트가 작성한 양식, 클라이언트의 이야기, 사회복지사가 관찰한 내용 및 클라이언트와의 직접적 상호작용 경험, 관련이 있는 사람으로부터 수집한 정보, 심리검사나 평가도구의 결과, 그 밖의 자료
- 클라이언트의 언어적 표현과 비언어적 행동이 일치하지 않을 경우 비언어적 표현에 더 주의를 기울여야 한다. 말로 표현하지 못하는 내용이 표정이나 태도로 반영되기 때문

Q. 자료 수집을 위한 자료 출처에 해당하는 것을 모두 고른 것은? (ㄱ,ㄴ,ㄷ,ㄹ)

- ㄱ. 문제, 사건, 기분, 생각 등에 관한 클라이언트 진술
- ㄴ. 클라이언트와 직접 상호작용한 사회복지사의 경험
- ㄷ. 심리검사, 지능검사, 적성검사 등의 검사 결과
- ㄹ. 친구, 이웃 등 클라이언트의 중요한 타인으로부터 수집한 정보

3. 사정

- 개입 과정 내내 지속, 인간과 환경에 대한 이중 초점, 클라이언트와 사회복지사의 상호작용 과정, 사고의 전개 과정, 수평적 탐색과 수직적 탐색, 지식 기반, 욕구발견과 문제정의, 강점 발견, 개별화, 판단, 한계
- 클라이언트 완전히 이해 X
- 문제형성 : 클라이언트가 제시한 '남편의 일중독' 문제를 '자신의 남편에게 중요한 존재임을 느끼고 싶어 하는' 욕구로 바꾸어 진술

4. 사정도구

- 사회적 관계망 격자 : 사회적 관계의 지지 정도와 질, 지지의 방향 파악
- 가계도 : 한 가족 사정도구, 가족의 과거부터 현재까지의 정보 포함, 사각형, 원, 선 사용
- 생태도 : 환경 속의 인간 관점, 가족의 자원, 가족과 외부 환경 간의 상호작용 묘사
- 생활력도표 : 생애 동안 발생한 사건이나 문제가 변화되어 가는 과정을 시간의 흐름에 따라
- 생활주기표 : 생애주기와 가족구성원의 발달단계별 과업을 표로 작성
- 가족조각 : 경험적 가족치료에서 사용되는 기법, 공간적으로 스스로 위치. 가족관계를 몸으로 표현하여 가족의 상호작용 양상을 나타냄
- 소시오그램

: 사정도구 중 집단성원들 간의 상호작용을 도식화하여 구성원의 지위, 구성원 간의 관계, 허위집단, 구성원 상호 간의 선택, 거부, 무관심 따위의 관계 등을 파악하는 데 유용

가계도

- 세대 간의 반복적 유형 분석
- 일반적으로 3세대를 포함
- 자녀는 출생순서에 따라 왼쪽부터 오른쪽으로 순차적으로 그림
- 친밀한 관계나 갈등관계와 같은 정서적 관계 포함
- 가족의 구조적 및 관계적 측면을 볼 수 있다.
- 여러 세대의 가족에 대한 정보를 얻을 수 있다.
- 가족의 문제를 체계적으로 이해할 수 있게 한다.
- 세대 간 반복되는 관계유형을 찾고 통찰력을 갖게 한다.

생태도

- 가족환경을 체계론적 관점에서 이해
- 가족이 이용하는 서비스기관의 종류
- 가족의 여가활동
- 이웃주민들과의 친밀도
- 확대가족과의 관계
- 자원체계 간의 에너지 흐름
- 스트레스가 되는 체계
- 자원 교환 정도
- 환경체계 변화가 필요한 내용
- 가족규칙은 알 수 없음. 가족의 상호작용 관찰 OR 가족들의 이야기를 통해 알 수 있음

Q. 생태도 작성에 관한 내용으로 옳은 것을 모두 고른 것은? (㉠,㉡,㉢)

- ㉠. 용지의 중앙에 가족 또는 클라이언트체계를 나타내는 원을 그린다.
- ㉡. 중심원 내부에 클라이언트 또는 동거가족을 그린다.
- ㉢. 중심원 외부에 클라이언트 또는 가족과 상호작용하는 외부체계를 작은 원으로 그린다.
- ㉣. 자원의 양은 '선'으로, 관계의 속성은 '원'으로 표시한다.
- > 자원의 양은 '원'으로, 관계의 정도, 속성은 '선'으로 표시
- > 관계의 기간, 관계의 역사, 관계의 원천은 생태도를 통해 알 수 없음
- > 굵은 실선은 강한 관계, 점선은 빈약하고 불확실한 관계
- 사선이나 지그재그 선은 긴장이나 갈등관계

5. 계획수립

: 표적문제 선정 - 표적문제 우선순위 결정 - 목표설정 - 과업구체화

6. 표적문제 선정

- 클라이언트가 중요하게 생각하고, 시급히 해결되기를 원하며, 문제상황을 대표 선택
- 너무 많이 정하면 계획된 시간 안에 해결하기 어려움
- 해결 가능성이 비교적 뚜렷한 문제를 2-3가지 정도 선택
- 사회복지사와 클라이언트 간 협의가 중요
- 어느 한쪽만의 의견에 따라 정하면 안 됨
- 사회복지사와 클라이언트 모두 '문제'라고 합의하고 해결하기를 바라는 것을 선택
- 표적문제 중에서 시급히 해결해야 할 문제 순으로 우선순위를 정하기
- 표적문제는 클라이언트가 이해하기 쉬운 용어로 기술
- 표적문제를 선정할 때 사회복지사 자신의 지식과 기술을 고려
- : 개입활동으로 해결이 가능해야 하기 때문

- 표적문제의 우선순위 결정에서 고려해야 할 사항
- : 긴급성, 변화 가능성, 해결 가능성, 클라이언트의 선택

7. 목적과 목표 구분

목적 : '해결책을 제시하는 방향'으로 목표보다 광범위하고 추상적인 개념

단기적인 개입목표가 달성됨으로써 결국 목적이 달성됨

- 장기적이고 긍정적인 결과의 형태로 제시
- 사회복지실천을 통해 변화되기 원하는 방향의 형태로 진술

목표 : 사회복지사와 클라이언트의 노력이 궁극적으로 향하고 있는 바람직한 결말

문제가 해결된 상태, 개입을 통해 일어나기 바라는 변화

목표는 목적을 세분화한 것으로 목적보다는 단기적이며 구체적

- 사회복지사의 전문적 판단으로만 설정 X
- 클라이언트가 바라는 바와 연결
- 여러 개일 경우에는 가장 시급한 것을 최우선순위로 정

8. 목표설정

- 희망하는 결과와 관련
- 명시적이며 측정 가능한 형태, 달성 가능한 것으로 설정
- 사회복지사의 지식, 기술에 상응
- 사회복지사의 가치나 권리를 크게 위배하지 않아야 함
- 성장을 강조하는 긍정적인 표현으로 기술
- 기관의 기능과 일치

SMART 형식에 따라 개입목표 설정

- 구체성(Specific)
- 측정 가능성(Measurable)
- 성취 가능성(Achievable)
- 현실성(Realistic) 및 결과 지향성(Result-oriented)
- 시기 적절성(Timely) 및 시간 구조화(Time frame)

적합성, 합리성, 조절가능성 X

9. 개입

- 직접 개입 : 상담, 가족치료, 정보제공, 교육 등
- 간접 개입 : 자원 개발, 서비스 조정, 프로그램 개발, 옹호
- 환경 조정
- 서비스 조정 : 서비스 간 중복이나 누락 없이 적절한 서비스 제공
- 프로그램 계획과 개발
- 공식적 지지체계의 활용
- 자연적 지지체계의 활성화
- 옹호

개입단계에서 사회복지사가 수행하는 과업

: 계획된 방법으로 서비스 제공, 계획 수정 필요시 재사정 실시

10. 종결 시 사회복지사 과업

계획된 종결 : 서비스의 제공 완료, 시간제한, 목표 달성

계획되지 않은 종결 : 클라이언트에 의한 OR 사회복지사에 의한 계획되지 않은 종결

종결단계의 과업

- 종결 시기 정하기
- 정서적 반응 다루기(긍정적 + 부정적)
- 효과의 유지와 강화
- 의뢰

: 일정 기간만 제공되는 서비스의 종결-서비스의 특성을 설명하고 필요한 경우 다른 기관에 의뢰, 종결유형에 따라 다르게 해야 한다.

- 평가 : 개입목표의 달성 여부를 확인한다.

11. 사후관리

- 종결 후 일정 기간(1개월 ~ 6개월)이 지나서 클라이언트가 잘 적응하고 있는지 확인
- 문제가 있는 경우 재개입
- 클라이언트의 변화 유지에 도움
- 종결로 인한 클라이언트의 충격 완화
- 클라이언트의 적응 상태 확인

12. 사회복지실천 평가

- 과정평가 : 개입 혹은 개선방안 마련 목적. 개입 과정에서 무엇이, 왜 일어났는지
- 결과평가(성과평가) : 종결. 목표 성취 여부, 결과 평가. 개입의 효과성
 - > 청소년을 위한 10주간의 진로집단 활동 전·후에 진로효능감 검사 후 결과 비교
- 형성평가 : 프로그램 개발 중 혹은 실행 초기 단계. 프로그램 개선, 조정 목적
- 총괄평가 : 최종 결론 형태. 목적과 목표가 충족되었는지, 개입 효과가 일반화 가능한지
- 만족도 평가 : 프로그램 만족도 평가
- 실무자평가 : 사회복지사가 클라이언트로부터 피드백을 받는 평가

사례관리

특성

- 욕구에 초점. 기관 내 서비스 한정 X
 - 단편화되고 파편화된 서비스를 통합적 관리. 공식적, 비공식적 자원 연계 및 조정
 - 서비스의 접근성 향상. 투입과 과정 평가
 - 개인의 자원 획득 및 활용 능력 강화 = 개인 및 환경의 변화를 위해 노력
- : 클라이언트 대신 해주는 것이 아님
- : 동기와 능력이 부족한 클라이언트가 문제를 해결하도록 동기화
- 서비스의 중복 가능성을 낮춰 자원 효율적 사용
 - 임상적 욕구를 가진 클라이언트에게는 치료적 상담 실시
 - 클라이언트의 가족과 일차집단의 클라이언트에 대한 보호능력 확대

사례관리 등장배경

- 탈시설화=지역사회 중심의 재가복지서비스 활성화
- 복잡하고 분산된 서비스 체계=서비스 전달의 지방분권화
- =서비스 전달체계 간 조정기능 부재=분산된 서비스의 조정기능 부재
- 클라이언트와 그 가족에게 부과되는 과도한 책임
- 만성적이고 복합적인 문제를 가진 클라이언트의 증가
- 기존 서비스의 단편성
- 사회적 지원과 사회적 지원망의 중요성에 대한 인식 증가
- 지역사회보호 필요성 증가

Q. 사례관리 등장 배경에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (5)

1. 탈 시설화로 인해 많은 정신 장애인이 지역사회 내에서 생활하게 되었다.
2. 지역사회 내 서비스 간 조정이 필요하게 되었다.
3. 복지비용 절감에 관심이 커지면서 저비용 고효율을 지향하게 되었다.
4. 인구·사회적 변화에 따라 다양하고, 복합적이며 만성적인 욕구를 가진 클라이언트가 증가하였다.
5. 사회복지서비스 공급주체가 지방정부에서 중앙정부로 변화하였다.

사례관리 개입원칙

- 서비스의 개별화
- 서비스 제공의 포괄성
- 클라이언트의 자율성 극대화
- 보호의 연속성 혹은 서비스의 지속성 : 중단되지 않고 지속적으로 원조
- 서비스 연계성 : 복잡하고 분리되어 있는 서비스 전달체계를 연결
- 서비스의 접근성
- 서비스의 체계성 : 유사한 서비스 중복을 줄이고 서비스와 자원들을 효율적으로 조정

※ 서비스의 표준화 및 체계화 X -> 표준화보다는 개별화

사례관리 과정

(아웃리치) -> 사정 -> 계획 -> 개입 -> 점검 -> 평가

자녀에게 인터넷 중독 검사를 실시하고, 아버지의 폭력 정도에 대해 자녀와 면담(사정)



지역사회 관련 전문가들이 모여 필요한 서비스 목록 작성(계획)



서비스를 제공하면서 자녀의 학교생활 변화 여부 점검(개입과 점검)



가족들에게 사례관리에 대해 어떻게 느꼈는지 설문조사(평가)

사례관리자 역할

- 조정가
- 중개자
- 옹호자
- 기획자
- 중재자

Q. 사례관리자 역할과 그 예의 연결로 옳지 않은 것은?

1. 조정자 : 사례회의를 통해 독거노인지원서비스가 중복 제공되지 않도록 하였다.
2. 옹호자 : 사례회의에서 장애아동의 입장을 대변하였다.
3. 협상가 : 사례회의를 통해 생활 형편이 어려운 가정의 아동에게 재정 후원자를 연결해주었다.
4. 평가자 : 사례 종결 여부를 결정하기 위해 목표 달성 여부를 확인하였다.
5. 기획자 : 욕구사정을 통해 클라이언트에게 필요한 자원을 설계하고 체계적인 개입 계획을 세웠다.

실천론은 전반적으로 난이도가 낮은 편이라서 공부 시간을 많이 투자하지 않아도 고득점 받을 수 있음.
실천론 고득점 맞고 실천기술론과 지역사회복지론 60점만 맞는다는 생각하면 좋음.